

## 23. DÉVELOPPEMENT DE L'OESOPHAGE

DURÉE : 07:43

FICHE PÉDAGOGIQUE

### RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur le développement de l'œsophage, soulignant son rôle essentiel en tant qu'articulation entre le mental et le cœur. On y aborde l'impact de la flexion embryonnaire sur le tronc, qui façonne le système digestif et permet la formation des poumons et de l'œsophage. Un focus est mis sur la structure adaptative de l'œsophage, son lien avec le diaphragme, et les conséquences des dysfonctionnements, notamment en matière de reflux et de problèmes ORL. Les interactions dynamiques entre l'œsophage, la trachée et l'aorte révèlent une complexité rythmique qui est cruciale pour notre santé globale. À travers des concepts clés tels que le plexus vagal et la vasculature péritonéale, cette leçon met en lumière l'importance du système embryonnaire pour la pratique ostéopathique.

### DÉVELOPPEMENT DE L'OESOPHAGE

Le développement de l'**œsophage** est une articulation entre le **mental** et le **cœur**. L'**aorte** joue un rôle central dans ce système, tandis que la **cavité amniotique** exerce une pression externe. Entre ces deux éléments, le **cerveau** oriente le développement et le **cœur** sert de point d'appui.

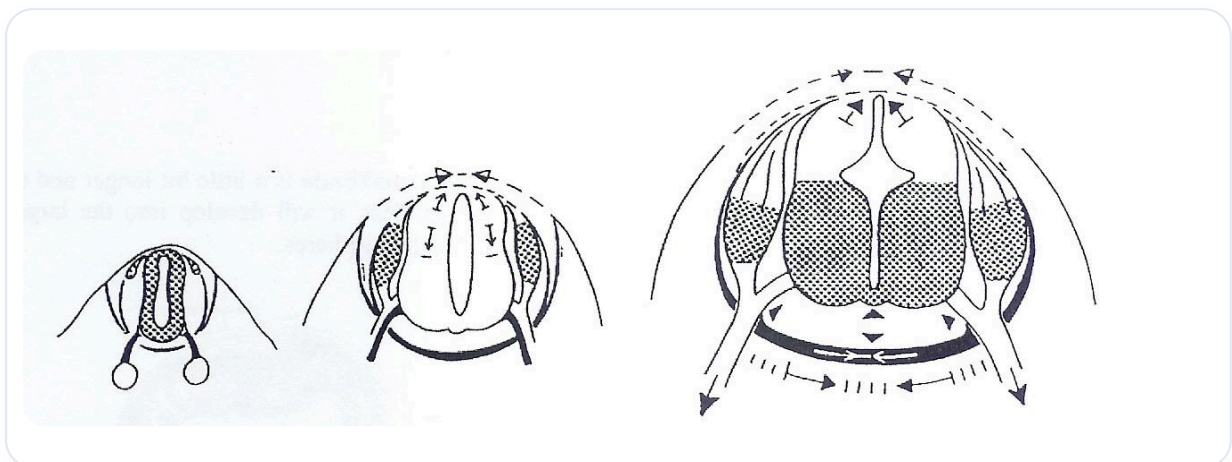
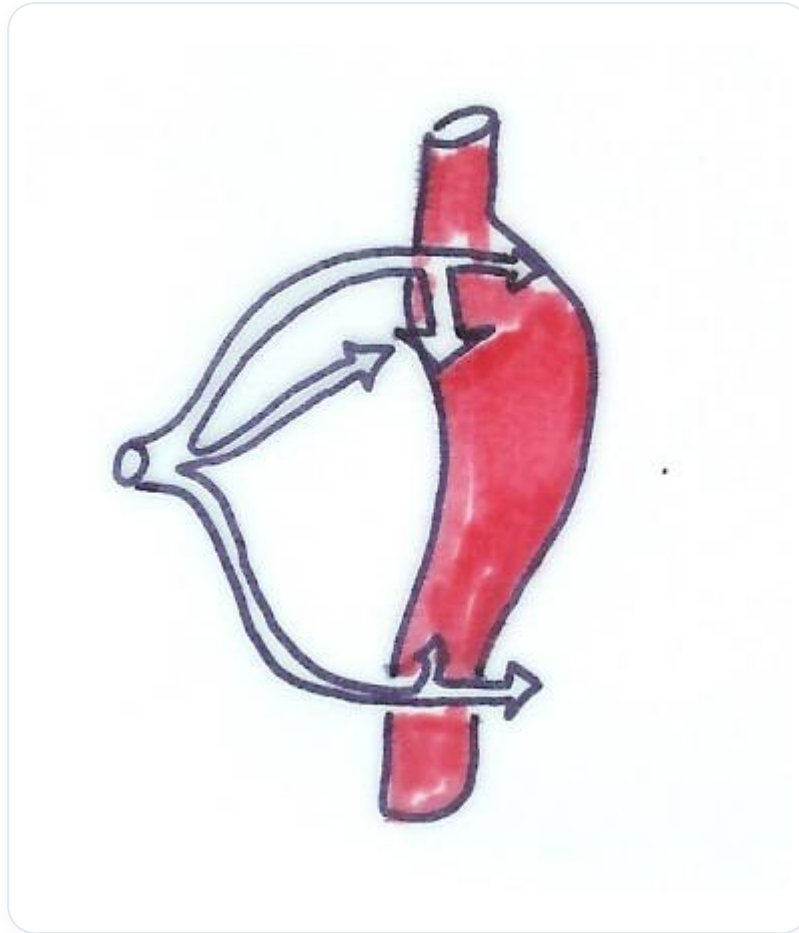


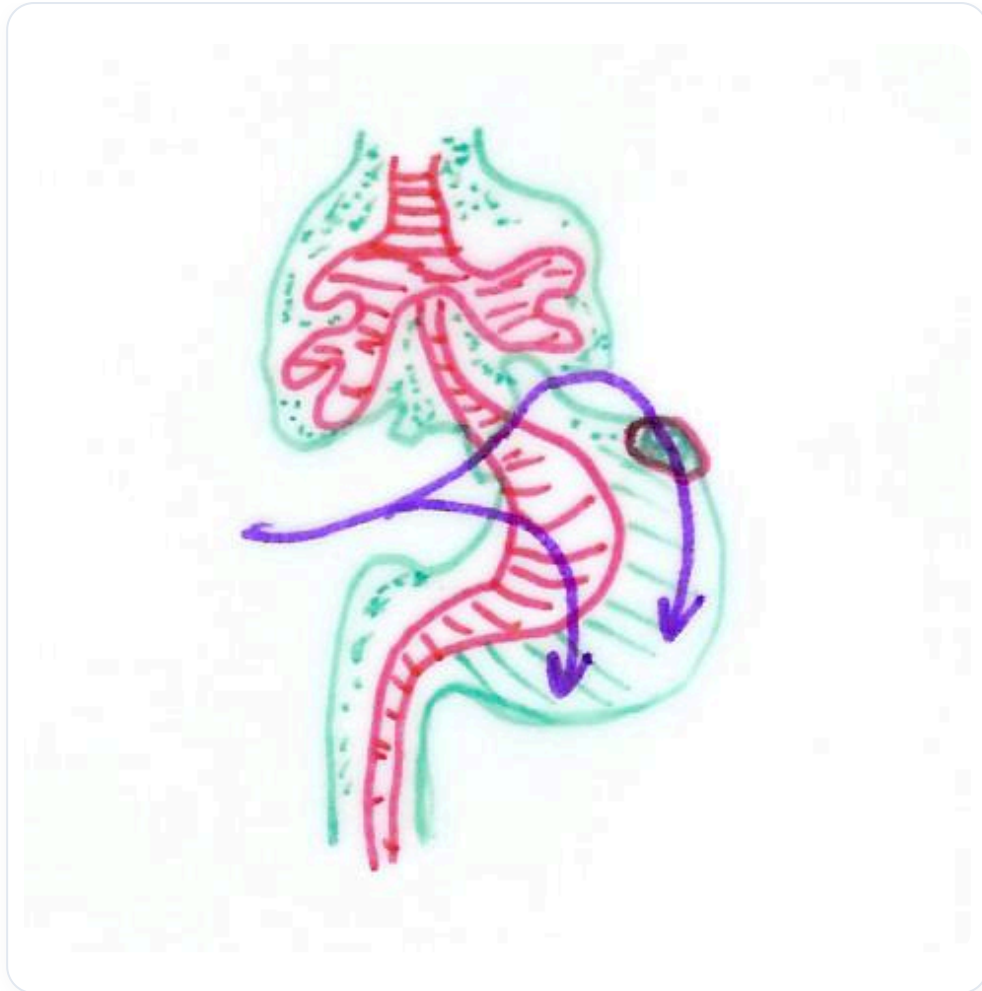
FIG. — Gastrulation neurulation invagination

Nous avons précédemment étudié l'influence de l'application du mouvement de flexion de l'embryon au niveau de la tête. À présent, nous allons examiner l'influence de cette application au niveau du **tronc**. Ce mouvement de flexion engendre divers phénomènes digestifs.



*FIG. — Circulation fœtale*

Un des premiers phénomènes digestifs à étudier est le développement des **poumons**, que l'on peut considérer comme une glande. Ce mouvement de flexion implique la **cavité amniotique**, la **cavité vitelline** et le **cœur**. Nous observons l'apparition du **tube digestif antérieur** avec des diverticules.



**FIG.** — *Circulation foetale*

Progressivement, une zone pulmonaire et une zone digestive se dessinent.

L'**œsophage** se développe à partir du segment de l'**intestin primitif**, situé entre le **diverticule respiratoire** et la dilatation de l'**estomac**. Il est constitué d'une partie **endoblastique** (tissu interne) et d'un **mésenchyme** (tissu conjonctif, musculaire et fibreux). L'épithélium forme la partie interne, tandis qu'autour se trouve un tissu qui contribue à sa structure.

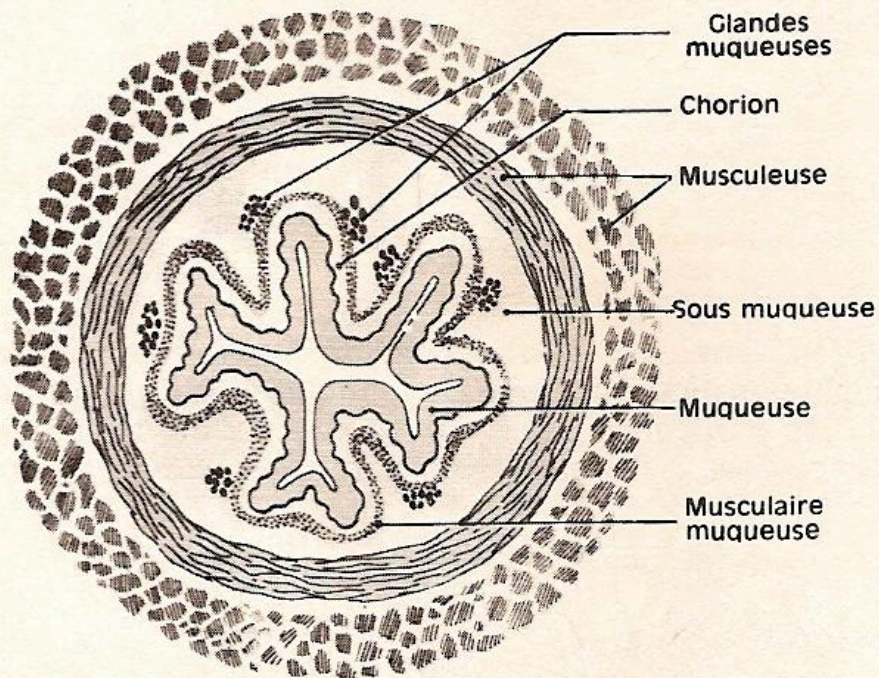


FIG. 53. — Coupe transversale de l'œsophage.

FIG. — Coupe œsophage

L'**œsophage** présente une certaine adaptabilité à son environnement. Cependant, de nombreux problèmes au niveau de la jonction œsophagienne sont liés à la relation avec le **diaphragme**. Ces dysfonctionnements peuvent entraîner des problèmes **ORL**, tels que des otites, des rhinites, et même des reflux gastriques. Des éléments tels que la **pepsine** et l'**acide chlorhydrique** ont été retrouvés dans l'oreille moyenne de certains enfants, soulignant le lien entre reflux et problèmes ORL.

Corte frontal esquemático del hiato esofágico.

- 1 Porción derecha del diafragma.
- 2 Músculo de Rouget y Juvara derecho.
- 3 Peritoneo.
- 4 Cardioesófago.
- 5 Válvula de Gubaroff.
- 6 Músculo de Rouget y Juvara izquierdo.
- 7 Espacio periesofágico.
- 8 Vaina de Treitz y Leimer (lado izquierdo).
- 9 Vaina de Treitz y Leimer (lado derecho).
- 10 Pleura.

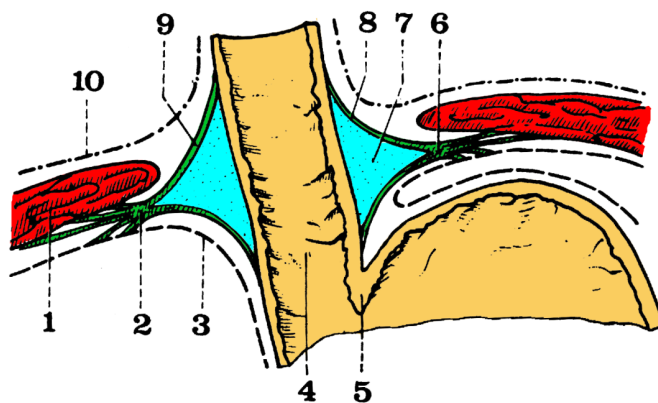
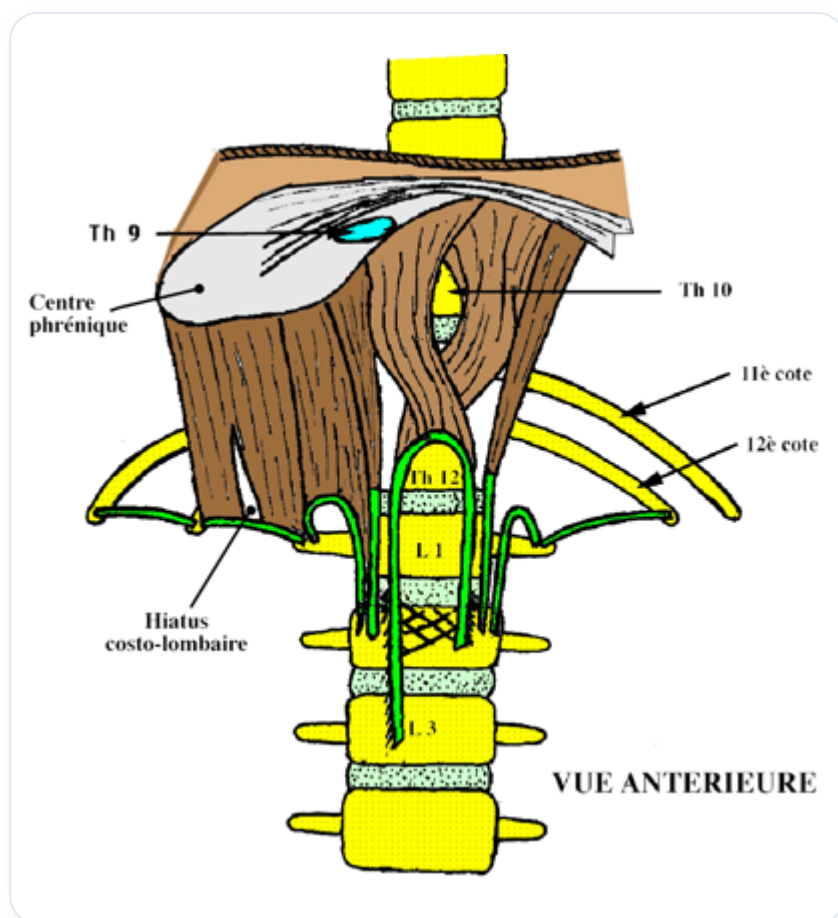


FIG. — Hiato esofágico

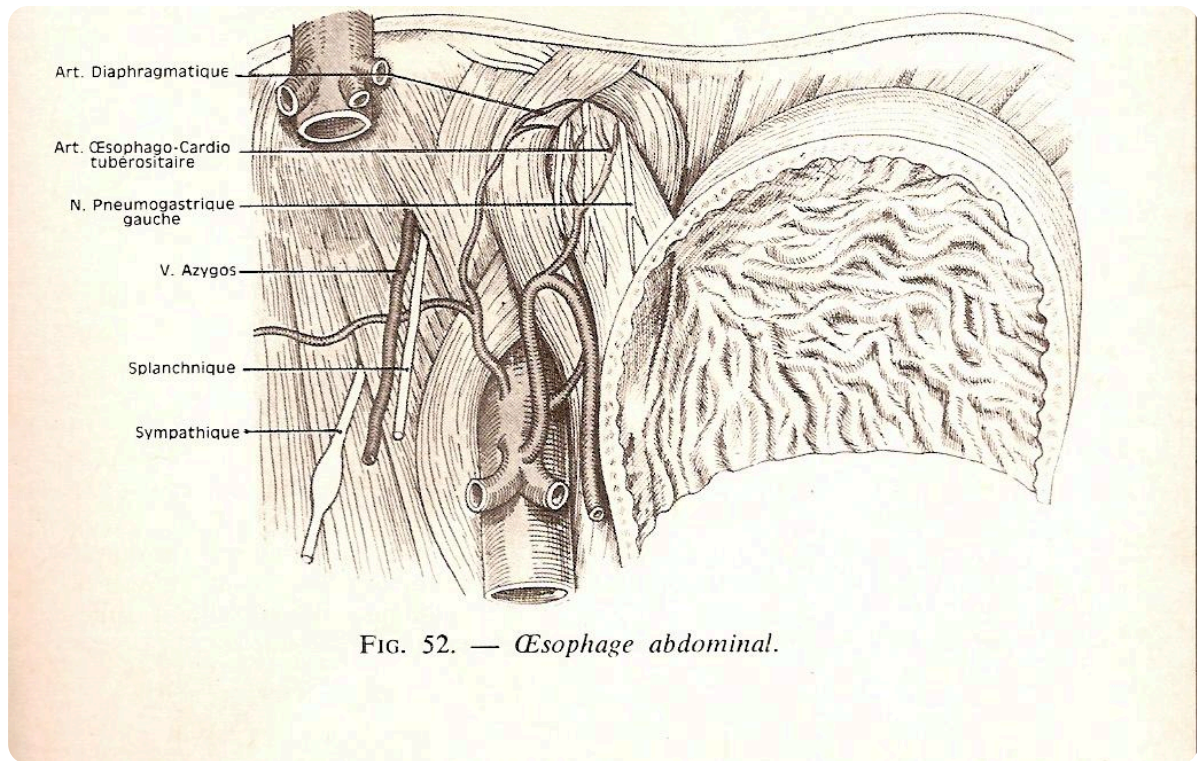
Il est important de noter que les reflux ne se manifestent pas toujours par des brûlures. En effet, certains reflux sont de type gazeux, impliquant des molécules de gaz qui remontent dans le système. Cela est souvent dû à une dysfonction au niveau de la jonction entre l'œsophage et l'estomac, au niveau diaphragmatique.



*FIG. — Diaphragme en vue antérieure*

La **jonction diaphragmatique** est cruciale, car elle est en rapport avec les **fibres de Juvara** et l'espace **péri-œsophagien**, qui est adaptatif. Une dysfonction à ce niveau peut bloquer la qualité et l'ouverture du diaphragme. Steele a dit : "Si ton diaphragme n'est pas libre, la porte de ta vie n'est pas libre."





*FIG. — Œsophage abdominal*

Le **plexus vagal** est également très important. L'**œsophage**, la **trachée** et l'**aorte** sont interconnectés, formant une zone rythmique.

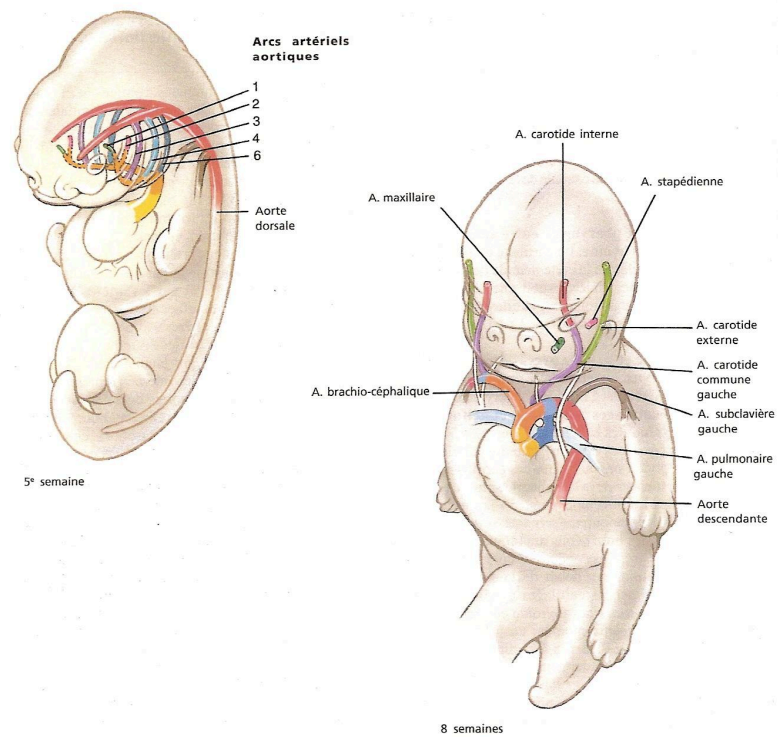
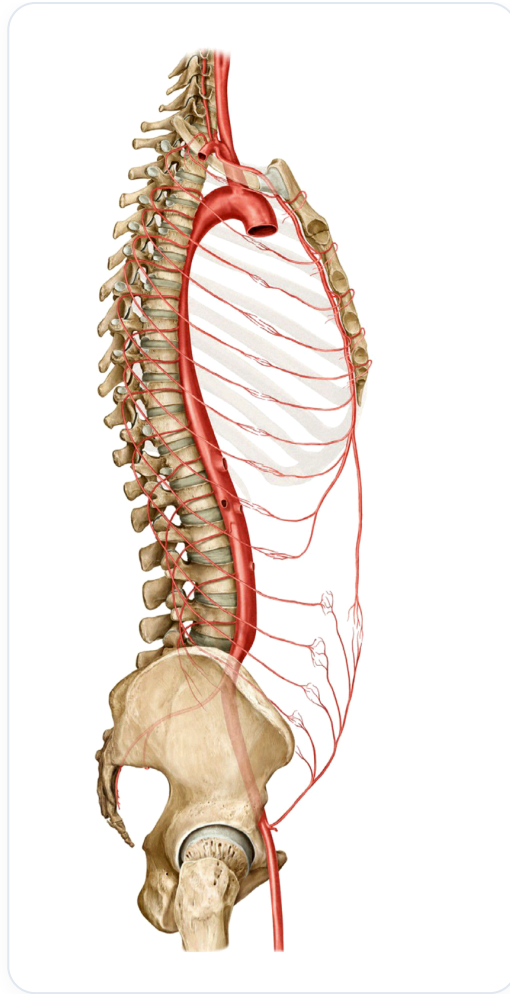


Fig. 12 - 6. Devenir des artères des arcs pharyngiens. Ces artères se modifient pour être à l'origine de celles de la partie supérieure du thorax, du cou et de la tête (voir Ch. 8).

FIG. — Arcs aortiques embryonnaires

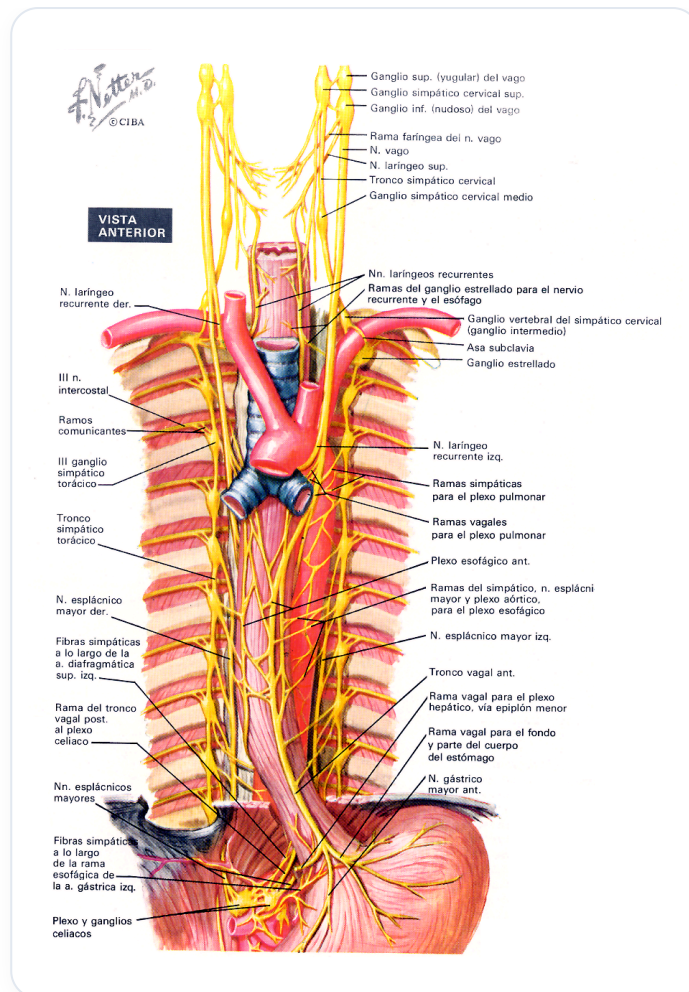
Cette zone est maintenue par un **fascia commun** et un **mésentaire postérieur**, qui s'insèrent sur la zone dorsale moyenne, autour de D3-D4.



*FIG. — Aorte, arc, intercostales*

L'**œsophage** est impliqué dans la déglutition, la **trachée** dans la respiration, et l'**aorte** dans le mouvement du cœur. Ces interactions se produisent des milliers de fois par jour, créant une dynamique rythmique complexe.





**FIG.** — *Innervation thoracique et abdominale*

Nous avons également une continuité directe avec le système aortique, ainsi qu'un ligament qui s'étend vers le **quatrième portion du duodénum**, ouvrant une zone importante au niveau du **tronc cœliaque**. Ce dernier est essentiel pour la vascularisation de la partie péritonéale sous-diaphragmatique, irrigant le **foie** et l'**estomac**.

Enfin, nous allons aborder l'étude des **poumons**, en passant en revue les différentes couches de l'œsophage et leur importance dans le développement global du système digestif.